CUESTIONARIO INFECTO 1	
1. Un paciente de 50 años, con antecedente de amigdalitis a repetición en la infancia, consulta por un cuadro de malestar general, asociado a fiebre. Su examen físico no es capaz de identificar un foco y sólo visualiza algunas petequias en las extremidades inferiores. ¿Qué conducta diagnóstica es más adecuada?	a.Solicitar hemocultivos y serología para Leptospira, Brucella y Bartonella b.Solicitar ecocardiografía y hemocultivos c.Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías d.Solicitar cintigrafía ósea e.Solicitar mielocultivo
2. El diagnóstico de infección del tracto urinario se establece cuando:	a.El urocultivo por orina de segundo chorro resulta positivo, con más de 1.000.000 de UFC por ml b.El urocultivo por orina de segundo chorro resulta positivo, con más de 100.000 UFC por ml c.El urocultivo por orina de segundo chorro resulta positivo, con más de 1.000 UFC por ml d.El sedimento de orina muestra más de 10 leucocitos por campo e.El sedimento de orina muestra más de 100 leucocitos por campo
3. Un niño presenta lesiones costrosas amarillentas alrededor de la boca y en las mejillas, que aparecieron hace 3 días, pero que han aumentado considerablemente de tamaño. El tratamiento antibiótico de elección es:	a.Amoxicilina b.Azitromicina c.Cloxacilina d.Ciprofloxacino e.Moxifloxacino
4. ¿Cuál de los siguientes antibióticos NO tiene cobertura para Pseudomona aureginosa?	a.Cefotaximo b.Ticarcilina c.Ciprofloxacino d.Gentamicina e.Imipenem
5. ¿Qué tratamiento indicaría a un paciente con una endocarditis por Enterococo resistente a ampicilina?	a.Penicilina b.Amoxicilina c.Ceftriaxona d.Imipenem e.Vancomicina
6. Un paciente de 28 años, presenta un cuadro de diarrea disentérica y fiebre hasta 38,7°C, de dos días de evolución. Refiere haber comido verduras sin lavar. El tratamiento antibiótico más adecuado es:	a.Metronidazol b.Amoxicilina c.Ciprofloxacino d.Clindamicina e.Claritromicina
7. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para una pielonefritis aguda en el embarazo?	a.Nitrofurantoína oral b.Clindamicina endovenosa c.Ceftriaxona endovenosa d.Macrólidos orales e.Ciprofloxacino endovenoso
8. Un paciente de 84 años consulta por un cuadro de tos con expectoración pútrida, de 5 días de evolución, asociado a malestar general. Se solicita una radiografía de tórax, que ve una imagen redondeada, de 5 cm de diámetro, con un nivel hidroaéreo, ubicada en el lóbulo inferior derecho. El tratamiento antibiótico más adecuado es:	a.Amoxicilina b.Clindamicina c.Ceftriaxona d.Cloxacilina e.Metronidazol
9. Un niño de 5 años presenta una meningitis bacteriana aguda, a germen desconocido. El tratamiento empírico más adecuado es:	a.Ceftriaxona + cloxacilina + dexametasona b.Penicilina + metronidazol + dexametasona c.Ceftriaxona + vancomicina + dexametasona d.Cefotaximo + ampicilina + dexametasona eClindamicina + gentamicina + dexametasona
10. Un niño de 7 años presenta un cuadro de rinorrea purulenta, de 7 días de evolución, a lo que luego se agrega eritema y dolor ocular derecho. Al examen físico se aprecia ligera proptosis, eritema periocular y oftalmoparesia del ojo derecho. La agudeza visual es normal. ¿Qué tratamiento antibiótico le parece más adecuado para este paciente?	a.Ceftriaxona más cloxacilina b.Cloxacilina c.Quinolona de segunda generación d.Macrólido e.Penicilina benzatina
11. Una paciente de 38 años presenta disuria y polaquiuria de 2 días de evolución. No ha	a.Esperar el resultado del urocultivo, sin iniciar antibióticos por el momento

Lia...

presentado fiebre ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes bacterias y 50 leucocitos por campo y un urocultivo, que está pendiente. La conducta más adecuada es:	b.Iniciar ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 3 días y controlar con el resultado del urocultivo c.Iniciar ceftriaxona endovenosa 1 gramo al día y controlar con el resultado del urocultivo d.Dar monodosis de nitrofurantoína y controlar con el resultado del urocultivo e.Indicar metronidazol 500 mg cada 8 horas por 7 días y controlar con el resultado del urocultivo
12. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es responsable de la mayoría de las sepsis asociada a catéter intravascular?	a.Estafilococo áureo b.Streptococcus pyogenes c.Estafilococo coagulasa negativo d.Pseudomona aureginosa e.Acinetobacter baumanii
13. Un paciente de 45 años, con antecedente de patología periodontal, consulta por aumento de volumen cervical, doloroso a la palpación. Al examen físico se aprecia una adenopatía de gran tamaño (4 cm), dolorosa a la palpación y con eritema de la piel que la recubre. El tratamiento antibiótico más adecuado es:	a.Macrólidos b.Ampicilina c.Metronidazol d.Amoxicilina más ácido clavulánico e.Ciprofloxacino
14. Un paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia, consulta por fiebre alta, malestar general y dolor en la extremidad inferior izquierda. Al examen físico se aprecia una zona eritematosa de 40 cm de largo en la cara interna del muslo izquierdo, con varias áreas violáceas y negruzcas, que es muy dolorosa. El tratamiento de la patología descrita es:	a.Cloxacilina + clindamicina por vía endovenosa b.Cloxacilina endovenosa + debridación quirúrgica c.Cefazolina endovenosa + debridación quirúrgica d.Penicilina endovenosa e.Penicilina + clindamicina endovenosa + debridación quirúrgica
15. Un paciente de 45 años, consulta en el policlínico de ETS por una lesión en el glande, ulcerada, de 6 mm de diámetro, indolora, de fondo limpio. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección. El resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar doxicilina oral b.Iniciar aclicovir oral c.Administrar penicilina benzatina intramuscular y realizar seguimiento con VDRL d.Solicitar FTA-ABS e.Iniciar tratamiento con penicilina sódica por vía I.V.
16. Un paciente de 80 años es diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera, por lo que inicia tratamiento con 4 fármacos. ¿Qué examen es más adecuado para el seguimiento de este paciente?	a.PPD b.Baciloscopías y cultivo para mycobacterias c.Radiografía de tórax d.PCR para TBC e.Pruebas hepáticas
17. Un paciente de 68 años, sin antecedentes de importancia, consulta por un cuadro de malestar general, asociado a fiebre alta, con calofríos y tos abundante, con expectoración, de 5 días de evolución. En el último tiempo ha presentado disnea, la que se ha vuelto de reposo y refiere que se siente muy mal. Al examen físico presenta FC: 113 x ´, PA: 120/80, FR: 35x', saturación 89% a FiO2 ambiental. Está disneico y la auscultación pulmonar demuestra crepitaciones en el pulmón derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra signos de condensación del lóbulo inferior derecho y el lóbulo medio. ¿Qué antibiótico es más adecuado para el tratamiento de este paciente?	a.Vancomicina b.Ceftriaxona c.Claritromicina d.Amoxicilina e.Amoxicilina + ácido clavulánico
18. Una paciente adulta mayor, presenta simultáneamente una neumonía y una infección urinaria baja. Usted decide dejar tratamiento ambulatorio para ambas. De entre los medicamentos mencionados a continuación, ¿cuál es el más adecuado?	a.Clindamicina b.Amoxicilina c.Ciprofloxacino d.Levofloxacino e.Azitromicina
19. Un paciente de 40 años, diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera, abandona el tratamiento antibiótico, habiendo completado sólo 4 meses de tratamiento. Usted lo recibe 3 semanas después y está asintomático, sin alteraciones en su examen físico y con baciloscopía negativa. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar PPD y radiografía de tórax b.Solicitar cultivo de Koch y derivar a especialista para iniciar tratamiento secundario c.Observar evolución d.Solicitar broncoscopía e.Retomar el tratamiento donde lo dejó, sin necesidad de exámenes

20. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para el tratamiento de una uretritis gonocócica?	a.Metronidazol 2 gramos V.O. por una vez b.Ceftriaxona 1 gramo E.V. cada 12 horas por 7 días c.Ceftriaxona 250 mg I.M. por una vez d.Doxiciclina 100 mg V.O. cada 12 horas por 10 días e.Penicilina benzatina 1,2 millones I.M. por una vez

CUESTIONARIO INFECTOLOGIA 2	
1. Un paciente de 35 años, diagnosticado de VIH recientemente, le pregunta por la necesidad de tratamiento. No ha presentado infecciones oportunistas y su examen físico es normal. En sus exámenes presenta Elisa VIH: positivo, Western Blot VIH: positivo, carga viral: 2.130 copias por ml, CD4+: 430. La recomendación más adecuada, de acuerdo a la OMS, es:	a.Debe recomendársele iniciar triterapia antirretroviral, de inmediato b.Debe iniciar profilaxis para penumocystis carinii de inmediato c.Debe iniciar triterapia y profilaxis para pneumocystis carinii de inmediato d.Debe iniciar monoterapia con zidovudina, de inmediato e.No debe iniciar terapia por ahora
2. Un paciente de 20 años consulta porque en sus deposiciones apareció un gusano de cerca de 12 cm de largo. Se solicita un parasitológico de deposiciones, que visualiza huevos de Ascaris lumbricoides. La conducta más adecuada es:	a.Observar evolución b.Iniciar metronidazol c.Iniciar praziquantel d.Iniciar albendazol e.Iniciar cotrimoxazol
3. Un paciente VIH positivo presenta un cuadro de una semana de cefalea y malestar general, al que luego se le agrega sopor. Se solicita un TAC, que no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar ceftriaxona endovenosa b.Iniciar cotrimoxazol c.Iniciar vancomicina + ampicilina + cotrimozaxol d.Solicitar serología para toxoplasma e.Solicitar punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo
4. Un lactante de 9 meses de edad presenta un cuadro de fiebre y aparición de un exantema generalizado, de un día de evolución, que inició como eritema, de predominio en los pliegues, el que luego fue seguido de aparición de múltiples bulas generalizadas, fáciles de romper. El tratamiento más adecuado es:	a.Penicilina endovenosa b.Cloxacilina + clindamicina endovenosas c.Vancomicina endovenosa d.Ceftriaxona endovenosa e.Aciclovir endovenoso
5. Un paciente de 20 años consulta por un cuadro de malestar general y fiebre alta, de una semana de evolución, asociada a odinofagia. Al examen físico presenta faringe eritematosa, con amígdalas aumentadas de tamaño, con exudado blanquecino en su superficie. Además, se palpan algunas adenopatías cervicales. Se indica amoxicilina oral, sin embargo, el paciente consulta al día siguiente por aparición de un exantema eritematoso generalizado. El diagnóstico de sospecha es:	a.Escarlatina b.Leptospirosis c.Síndrome retroviral agudo d.Mononucleosis infecciosa e.Enfermedad por arañazo de gato
6. Un paciente de 56 años, sin antecedentes de importancia, se realiza un TAC de cerebro, como parte del estudio de una migraña. Se aprecian dos imágenes compatibles con neurocisticercos, calcificados, de 3 mm de diámetro cada uno. La conducta más adecuada es:	a.Resolver quirúrgicamente de inmediato b.Iniciar tratamiento con praziquantel por 6 semanas y realizar punción de los neurocisticercos con suero hipertónico c.Iniciar tratamiento con nifurtimox d.Iniciar anticonvulsivantes profilácticos e.Observar evolución
7. El tratamiento antibiótico empírico de la meningitis bacteriana aguda durante el embarazo debe ser:	a.Ampicilina + metronidazol b.Ceftriaxona + metronidazol c.Ceftriaxona + vancomicina d.Ceftriaxona + penicilina e.Ampicilina + ceftriaxona + vancomicina
8. ¿Cuál de los siguientes tratamientos NO tiene cobertura para anaerobios?	a.Penicilina G b.Moxifloxacino c.Clindamicina d.Metronidazol e.Gentamicina
9. Un paciente VIH positivo, sin tratamiento, consulta por disfagia de 5 días de evolución. Al examen físico presenta algorra en la cavidad oral y se palpan algunas adenopatías cervicales. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar tratamiento con fluconazol oral b.Iniciar tratamiento empírico con antimicóticos, ganciclovir y aciclovir oral c.Iniciar tratamiento con cotrimoxazol + macrólidos d.Solicitar PPD e.Solicitar endoscopía digestiva alta
10. Un paciente de 50 años consulta por malestar general, fiebre y tos con expectoración mucopurulenta de 4 días de evolución. Refiere que ha presentado hasta 40°C y presenta calofríos solemnes. Al examen físico se constatan crépitos	a.Mycoplasma pneumoniae b.Estafilococo dorado c.Neumococo d.Anaerobios e.Pseudomona aureginosa

Lia...

en la base pulmonar derecha, asociada a respiración soplante y aumento de la transmisión de la voz, por lo que se solicita una radiografía de tórax, que muestra condensación de todo el lóbulo inferior derecho. Su frecuencia respiratoria es 22x' y satura 96% a FiO2 ambiental. El agente etiológico más probable es:	
11. Un paciente de 66 años, oriundo de Aysén, consulta por tos intensa, asociada a salida de líquido transparente, con presencia de membranas, como hollejo de uva. Se solicita una radiografía de tórax, visualizándose una imagen compatible con un quiste hidatídico. ¿Cómo se contrajo esta enfermedad?	a.Por ingerir alimentos contaminados con deposiciones de perro b.Por ingerir alimentos contaminados con deposiciones humanas c.Por ingerir plantas acuáticas contaminadas d.Por ingerir carnes contaminadas e.Por la picadura de un insecto
12. Un paciente de 32 años consulta por disuria intensa. Refiere haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Al examen físico se aprecia eritema y secreción uretral purulenta y se aprecia que la ropa interior del paciente está manchada con dicha secreción. Usted está en un centro, que no dispone de exámenes de laboratorio. ¿Cuál de las siguientes alternativas es válida para tratar empíricamente a este paciente?	a.Cefxtriaxona intramuscular en una dosis, más doxiciclina por 10 días b.Clindamicina oral más amoxicilina por 10 días c.Metronidazol oral en monodosis d.Azitromicina por 10 días e.Penicilina benzatina en una dosis más ceftriaxona en una dosis
13. Un paciente de 56 años, diagnosticado de hepatitis crónica, se realiza exámenes en busca de virus de la hepatitis. Obtiene los siguientes resultados: IgG-VHC(+), IgG-VHBs(+),IgG-VHBc(+), IgM-VHBc(-), Ag-VHBs(-). El diagnóstico más probable es:	a.Hepatitis B aguda b.Hepatitis B crónica c.Hepatitis B y C crónicas d.Hepatitis C crónica e.Hepatitis de otra causa
14. El “periodo de ventana” de la infección por VIH se explica por:	a.El tiempo que toma al virus replicarse hasta alcanzar niveles detectables de partículas virales b.El tiempo que el virus permanece latente, sin replicarse c.El tiempo que toma al sistema inmune producir anticuerpos contra el virus d.El tiempo que toma al virus para deteriorar el sistema inmune, de modo de volver al organismo susceptible para las infecciones oportunistas e.El tiempo que toma a los linfocitos T CD4 positivos infectarse con el virus
15. El tratamiento de la neumonía por Pneumocystis jiroveci, en el paciente VIH, es:	a.Albendazol b.Metronidazol c.Anfotericina B d.Cotrimoxazol e.Fluconazol
16. Un paciente de 40 años, consulta por un cuadro de fiebre alta, mialgias intensas, cefalea retroocular y malestar general, que inició hace 48 horas. No presenta signos respiratorios y su examen cardiopulmonar es normal. Como dato importante, refiere haber viajado a Brasil recientemente. Se solicita un hemograma que muestra Hcto: 54%, plaquetas: 50.000 por mm3, blancos: 4.000 por mm3, con 90% de linfocitos. El diagnóstico más probable es:	a.Malaria b.Esquistosomiasis c.Dengue d.Fiebre amarilla e.Fiebre tifoidea
17. Un paciente de 10 años consulta por odinofagia, fiebre y aparición de lesiones en la cavidad oral. Al examen físico se aprecian múltiples úlceras orales, ubicadas en la lengua, las encías y el paladar, asociadas a adenopatías cervicales bilaterales. El agente etiológico más probable es:	a.Virus Coxsackie b.Virus herpes simplex c.Adenovirus d.Virus varicela zoster e.Streptococcus pyogenes
18. El tratamiento de la tiña capitis en los niños se realiza con:	a.Terbinafina tópica b.Clotrimazol tópico c.Ketoconazol oral d.Griseofulvina oral e.Itraconazol endovenoso
19. Un niño presenta un cuadro de fiebre alta,	a.Sarampión

calofríos, tos y conjuntivitis bilateral, a lo que se agrega un exantema rojo intenso generalizado, que inició en la cara y luego se extendió al resto del cuerpo. El cuadro descrito es característico de:	b.Rubéola c.Eritema infeccioso d.Exantema súbito e.Escarlatina
20. El tratamiento antibiótico de elección de la infección por C. difficile no complicada es:	a.Ciprofloxacino b.Azitromicina c.Vancomicina d.Clindamicina e.Metronidazol

CUESTIONARIO INFECTOLOGIA 3	
1. ¿Cuál de los siguientes es un tratamiento adecuado para una pielonefritis aguda, en un paciente ambulatorio?	a.Ciprofloxacino b.Nitrofurantoína c.Amoxicilina d.Clindamicina e.Cloxacilina
2. Un paciente de 59 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos con expectoración mucopurulenta de dos días de evolución. Al examen físico está en buenas condiciones generales, eupneico y con signos vitales normales, pero se auscultan crepitaciones localizadas en el lóbulo superior izquierdo. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra una imagen de condensación en dicho lóbulo. El tratamiento antibiótico más adecuado para este paciente es:	a.Amoxicilina b.Clindamicina c.Penicilina G d.Amoxicilina +ácido clavulánico e.Moxifloxacino
3. Una paciente de 91 años es diagnosticada de meningitis bacteriana aguda, a germen desconocido. El tratamiento antibiótico empírico recomendado es:	a.Ceftriaxona+ ampicilina + vancomicina b.Gentamicina + ceftriaxona c.Ceftazidima + amykacina d.Clindamicina + vancomicina e.Cloxacilina + metronidazol + cefotaximo
4. Un paciente consulta por fiebre y aparición de una zona roja en la pierna izquierda, caracterizada por una placa sensible, de 10 cm de diámetro mayor, de bordes claramente definidos. El tratamiento de elección es:	a.Clindamicina b.Vancomicina c.Penicilina d.Macrólido e.Ceftriaxona
5. Un paciente de 22 años, es diagnosticado de una neumonía intrahospitalaria, por lo que se solicita cultivo de expectoración, que resulta positivo para pseudomona aureginosa. El estudio de sensibilidad está aún pendiente. ¿Cuál de los siguientes tratamientos le parece más acorde para esto?	a.Amykacina + Ceftazidima b.Ceftriaxona + metronidazol c.Cefazolina + clindamicina d.Penicilina en dosis altas e.Ampicilina + clindamicina + eritromicina
6. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de elección para una sepsis por Klebsiella BLEE (betalactamasa de espectro expandido)?	a.Cefotaximo b.Cefoperazona c.Cefepime d.Imipenem e.Levofloxacino
7. Un paciente de 20 años presenta un cuadro de rinorrea y tos de 15 días de evolución, que en último tiempo ha empeorado, agregándose disnea de esfuerzos. Al examen físico presenta buen estado general, con normalidad de las frecuencias cardíaca y respiratoria, la presión arterial y la saturación arterial de oxígeno. Tiene sibilancias y crepitaciones bilaterales y está febril a 38°C. Su radiografía de tórax muestra un patrón alveolointersticial bilateral, con engrosamiento peribronquial. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar cultivo de expectoración y hemocultivos b.Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral c.Iniciar ceftriaxona endovenosa d.Iniciar azitromicina oral e.Iniciar clindamicina oral
8. Un paciente inicia tratamiento antituberculoso, por una tuberculosis pulmonar bacilífera. Usted lo controla cuatro meses después con una baciloscopía, la que resulta positiva. Al revisar las baciloscopías de los meses previos, usted nota que todas han estado positivas. Él refiere buena adherencia al tratamiento y mejoría sintomática. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar nueva radiografía de tórax b.Solicitar PPD c.Mantener el tratamiento y controlar en un mes con nueva baciloscopía d.Realizar biopsias pleurales e.Solicitar cultivo para mycobacterias y derivar a especialista por fracaso del tratamiento
9. Un paciente presenta fiebre y malestar general de 4 días de evolución. En su examen físico presenta un soplo sistólico, por lo que se solicita una ecocardiografía, que muestra vegetaciones mitrales, con una insuficiencia mitral severa. El agente más probable es:	a.Streptococcus pneumoniae b.Estafilococo coagulasa negativa c.Estafilococo áureo d.Streptococcus viridans e.Streptococcus pyogenes
10. La conducta con mayor efectividad para tratar una infección asociada a catéter intravascular por Staphilococcus coagulasa negativo es:	a.Iniciar penicilina benzatina intramuscular b.Iniciar penicilina endovenosa c.Iniciar cloxacilina endovenosa

Lia...

	d.Iniciar vancomicina endovenosa e.Retirar el catéter
11. El metronidazol es un antibiótico capaz de tratar las infecciones causadas por:	a.Cocáceas Gram positivas b.Bacilos Gram negativos c.Histoparásitos como el Tripanosoma y el Plasmodium d.Enteroparásitos unicelulares como la Entoameba y la Giardia e.Mycobacterias
12. Una paciente con promiscuidad sexual, se realiza exámenes de chequeo, entre los que destaca un VDRL, que resultó positivo. Se solicita MHA-TP el que resulta negativo. La explicación más razonable es que:	a.Tuvo un cuadro previo de sífilis, que fue adecuadamente tratado b.Se trata de un falso positivo del VDRL c.Presenta una coinfección entre sífilis y VIH d.Presenta una sífilis latente tardía e.Presenta una sífilis latente precoz
13. ¿Cuál de los siguientes tratamientos antibióticos NO tiene una buena cobertura para las enterobacterias?:	a.Metronidazol b.Gentamicina c.Ceftriaxona d.Cefazolina e.Levofloxacino
14. Un paciente de 40 años recibe amoxicilina + ácido clavulánico por 10 días, debido a una sinusitis bacteriana aguda, evolucionando favorablemente. Sin embargo, inicia diarrea acuosa abundante y dolor abdominal. Se solicita PCR para C. difficile en deposiciones, la que resulta positiva. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar moxifloxacino b.Iniciar clindamicina c.Iniciar vancomicina + clindamicina d.Iniciar vancomicina + gentamicina e.Iniciar metronidazol
15. Un paciente de 20 años, presenta un cuadro sugerente de meningitis bacteriana aguda, por lo que se decide realizar una punción lumbar que da salida a un líquido cefalorraquídeo inflamatorio, turbio, con más de 1.000 células por mm3, con predominio polimorfonuclear. Además, se aprecian abundantes cocáceas Gram positivas, en disposición en cadenas cortas y diplos. El agente etiológico más probable es:	a.Neisseria meningitidis b.Listeria monocytogenes c.Haemophilus influenza d.Neumococo e.Estreptococo grupo A
16. Un paciente de 45 años presenta un cuadro de 10 días de malestar general, asociado a fiebre alta y diarrea. Al examen físico presenta además un exantema rosado, por lo que se solicitan exámenes generales, destacando un hemograma, que sugiere fiebre tifoidea (leucopenia + desviación izquierda + aeosinofilia). El examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica es:	a.Mielocultivo b.Hemocultivo c.IgG para Salmonella typhi d.IgM para Salmonella typhi e.Inmunofluorescencia directa para Salmonella typhi en deposiciones
17. Un paciente presenta una infección de una herida operatoria, por un Staphilococcus aureus, que el antibiograma resultó sensible a la meticilina. ¿Qué tratamiento es el más aconsejado?	a.Piperacilina b.Cloxacilina c.Ceftriaxona d.Linezolid e.Vancomicina
18. Un paciente de 60 años, indigente, es diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera. Inicia tratamiento con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, el que recibe por 2 meses. Posteriormente no acude a los siguientes controles, ni continúa el tratamiento. Usted lo recibe 2 meses más tarde, asintomático, sin alteraciones evidentes. Se solicita baciloscopía, que resulta positiva. La conducta más adecuada es:	a.Dar de alta b.Reiniciar el tratamiento desde el inicio c.Derivar para inicio de tratamiento secundario, con al menos 5 fármacos d.Continuar el tratamiento con isoniazida y rifampicina por 4 meses más e.Solicitar cultivo para Mycobacterias y decidir conducta según resultado
19. ¿Cuál de las siguientes alternativas es más adecuada para el tratamiento de una amigdalitis de origen bacteriano por S. pyogenes?	a.Penicilina b.Cloxacilina c.Cefuroximo d.Ciprofloxacino e.Cotrimoxazol
De elección se usa la penicilina benzatina 1,2 millones de unidades por una vez, o la amoxicilina por 10 días. En alérgicos, se prefieren los macrólidos. La cloxacilina y el cefuroximo sí lo cubren, pero tienen un espectro más amplio del necesario. La respuesta correcta es: Penicilina	

Lia...

20. La mayoría de las osteomielitis en el adulto mayor son producidos por:	a.Pseudomona aureginosa b.Bacteroides fragilis c.Streptococcus pyogenes d.Staphilococcus aureus e.Streptococcus viridans

Lia...